

PRÓTESIS FIJA IMPLANTOSOPORTADA

En cumplimiento de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, le presentamos para su firma el siguiente documento:

D./Dña., con documento, como paciente, declaro que el Dr./la Dra., con número de colegiado, me ha diagnosticado:

El paciente es menor de edad. Consigne a continuación el nombre y documento del padre, madre o tutor que presta el consentimiento en su representación.

Nombre y apellidos:

Documento de identidad:

Parentesco o relación con el paciente:

Para dicho diagnóstico me ha propuesto y presupuestado el siguiente plan de tratamiento:

Piezas:

En relación con el diagnóstico, el facultativo me ha explicado, y comprendo, que:

Los procedimientos propios de la prótesis fija implantoportada van dirigidos a la sustitución de los dientes perdidos para así reparar la pérdida o disminución de las funciones masticadora y fonatoria, y limitar el defecto estético, mediante aparatología que el paciente no puede retirar por sus propios medios. Este tipo de prótesis va sujeta sobre implantes y en el momento de su colocación han de estar ya osteointegrados. Es evidente que la función esperable de una prótesis nunca será la misma que la que proporcionaron los dientes naturales. La prótesis fija implantoportada es en la que la estructura protésica puede ir atornillada o cementada sobre unos vástagos (pilares) atornillados, a su vez, a los implantes. Si se trata de prótesis fijas implantoportadas cementadas, el cemento, generalmente de carácter temporal (para permitir el desmontaje de la prótesis, en caso de aparecer algún tipo de patología periimplantaria, está llamado a experimentar degradación con el paso de un tiempo no excesivo y producir despegamiento de la prótesis, salvo cuando se emplean cementos definitivos, que pueden imposibilitar el levantamiento de la prótesis sin deteriorarla o tener que destruirla. Deberá consultar inmediatamente tan pronto como perciba movimiento en la misma, a fin de proceder a su recementado. Una variante de ésta es la llamada prótesis híbrida que, siendo fija, recuerda a la removible por la presencia de una falsa encía que permite restaurar con un símil de encía los tejidos óseos perdidos por el edentulismo.

Alternativas terapéuticas

Las alternativas terapéuticas a los tratamientos de prótesis fija sobre implantes pueden ser de distinto tipo según las características del paciente: prótesis removibles, prótesis fijas dentosoportadas (que implican el tallado o "rebaje" de los dientes pilares, etc). En este caso concreto las alternativas terapéuticas son:

Limitaciones y riesgos

EV/la paciente ha sido informado/a y conoce los riesgos e inconvenientes estadísticamente frecuentes que puede comportar este tratamiento:

- Problemas de adaptación a la prótesis. Una prótesis fija no deja de ser un cuerpo extraño que se instala en la boca intentando sustituir las funciones dentarias y por lo tanto requerirá un tiempo de adaptación que variará según la situación del paciente y el tipo de prótesis. Requerirá adaptación para la correcta masticación, posibles mordeduras, e hipersalivación en algunos individuos. Estos inconvenientes suelen pasar, pero en algunos pacientes persisten en un grado variable
- Riesgo de no responder a las expectativas estéticas de los pacientes. Es preciso tener claro que estas prótesis, por sus materiales y sistemas de retención nunca podrán igualar la estética de los: dientes naturales. Este tipo de prótesis precisan, además, espacios para asegurar la posibilidad de una correcta higiene alrededor de los implantes, espacios que pueden afectar a la estética a nivel gingival dejando "espacios oscuros" que podrían ser visibles en algunas circunstancias

Las prótesis implantosoportadas llamadas prótesis híbridas plantean mayores dificultades para conseguir una buena higiene, que, de no realizarse concienzudamente, puede causar halitosis y poner en peligro la duración de los implantes.

Además la anchura dentaria vendrá determinada por el diámetro del implante que se haya podido utilizar y el ángulo de éste.

Es importante destacar que la pérdida de hueso (reabsorción) que se produce después de la E pérdida del diente propio no se recupera cuando se colocan los implantes y la prótesis fija implantosoportada. El hundimiento que a veces se aprecia en el labio superior, en la zona canina

- en otras localizaciones debido a la pérdida de hueso, no se solucionará completamente de esta
- Riesgo de pequeñas zonas de inflamación en la encía alrededor de las coronas. La prótesis es un cuerpo extraño y hay que extremar la higiene en toda la zona, en especial si por motivos estéticos la corona se sitúa parcialmente subgingival
- Riesgo de que se introduzcan restos de alimentos bajo la prótesis o en los espacios vacíos que debe respetar
- Riesgo de fractura de los materiales o despegamiento o aflojamiento de los sistemas de retención de la prótesis con el paso del tiempo. No hay que olvidar que las prótesis dentarias soportan grandes fuerzas masticatorias, y que esto, irremediablemente, afectará a los materiales y requerirá su sustitución
- Riesgo de que el paciente manifieste o desarrolle algún tipo de intolerancia o alergia a los materiales de los que está construida la prótesis. Esta circunstancia es muy rara, difícilmente previsible, y de difícil solución salvo la sustitución de la prótesis

El paciente también ha sido informado de que las prótesis fijas implantosoportadas, debido a las fuerzas que soportan y al paso del tiempo, sufrirán deterioros (fisuras, roturas, despegamientos, etc) que harán necesario su renovación periódica. Igualmente ha sido informado de que la propia prótesis facilita la acumulación de placa bacteriana, hecho que puede dañar las encías, y que deberá ser eliminada mediante una detenida higiene de la prótesis y de los dientes remanentes después de cada comida. Para prevenir estas circunstancias se le informa que debe seguir las instrucciones dadas por su dentista y a someterse a revisiones periódicas, en ningún caso espaciadas más seis meses, y siempre que tenga cualquier tipo de molestia o duda sobre el tratamiento. Estas revisiones pueden implicar la necesidad de desmontar la prótesis para su completa higiene y reajuste.

Riesgos personalizados

Asimismo, D./Dña., por sus especiales condiciones particulares, puede presentar riesgos añadidos consistentes en:

Contraindicaciones

He informado al facultativo de mi estado de salud, de las enfermedades que padezco o he padecido, de la medicación que tomo actualmente y de mis alergias conocidas. Comprendo que determinadas condiciones médicas, tratamientos farmacológicos o hábitos pueden desaconsejar este tratamiento, obligar a modificarlo o empeorar su pronóstico, y que el facultativo me ha explicado si alguna de ellas concurre en mi caso.

Contraindicaciones específicas advertidas en mi caso:

Yo, D./Dña., como paciente, he sido informado/a por el Dr./la Dra., comprendo el alcance y el significado de dicha información, he podido formular cuantas preguntas he considerado oportunas y se me han aclarado todas las dudas, y consiento en someterme al procedimiento clínico descrito en este documento.

También he sido informado/a de la posibilidad de revocar este consentimiento por escrito y en cualquier momento, sin necesidad de expresar el motivo, incluyendo las posibles consecuencias que conlleva el no someterse al tratamiento propuesto, así como los riesgos que de esta decisión pudieran derivarse en relación con mi salud bucodental.

Información sobre protección de datos

Responsable: CLINICA IMPLANTDENT SL, CIF B17962564, con domicilio en Carrer de Santa Eugènia, 2. Finalidad: la prestación de asistencia odontológica y la gestión de su historia clínica. Legitimación: el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva, diagnóstico médico y prestación de asistencia sanitaria (art. 9.2.h del Reglamento (UE) 2016/679), así como para el cumplimiento de las obligaciones legales del centro.

Conservación: su historia clínica se conservará durante los plazos legalmente establecidos, con un mínimo de quince años desde el alta de cada proceso asistencial. Destinatarios: no se ceden datos a terceros salvo obligación legal o cuando resulte necesario para su asistencia. Derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose a info@dentalimplantdent.com, así como presentar una reclamación ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En Girona, a

El paciente

El odontoestomatólogo informante

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.